TUMOR CARCINOIDE

DR. JAMES LINDSAY

EPIDEMIOLOGÍA
- Tumor más frecuente del apéndice (60–80% de las neoplasias apendiculares); 0,3–0,9% de las apendicectomías.
- Predominio en mujeres (2:1); edad promedio 30–40 años.
- Más frecuente en la punta (70–80%), luego cuerpo y base; casi siempre pequeño y asintomático.

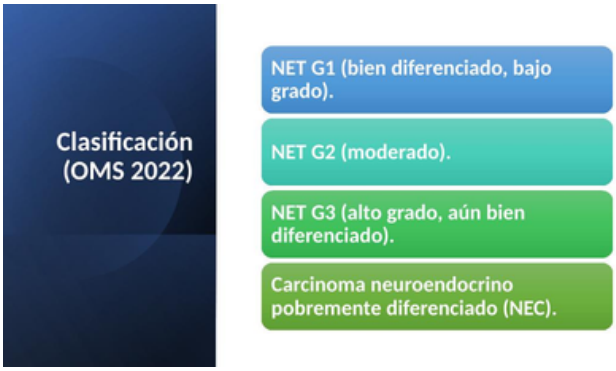
FISIOPATOLOGÍA
- Deriva de las células enterocromafines (Kulchitsky); secreta serotonina, histamina y otras aminas vasoactivas.
- Rara vez causa síndrome carcinoide: drena primero al hígado portal, donde se inactivan las aminas.

FACTORES DE RIESGO METASTÁSICO
- Tamaño, localización (base frente a punta), invasión linfovascular o mesoapendicular y grado histológico.

PRESENTACIÓN CLÍNICA
- 90% en contexto de apendicitis aguda: dolor en FID, náuseas, fiebre.
- Hallazgo incidental en la patología; síndrome carcinoide <1%.

DIAGNÓSTICO
- Macroscópico: tumor amarillento, bien delimitado y firme.
- Histopatología: nidos, cordones o trabéculas; cromogranina A, sinaptofisina y Ki-67 bajo.

ESTUDIOS DE EXTENSIÓN
- TAC/RM en tumores >2 cm o sospechosos; cromogranina A y 5-HIAA (rara vez necesarios en lesiones pequeñas).



TUMOR MENOR DE 1 CM
- Sin factores de riesgo: apendicectomía simple suficiente (guías ENETS/NCCN 2024).

TUMOR DE 1 A 2 CM
- Punta, sin invasión mesoapendicular y márgenes negativos → apendicectomía.
- Base, invasión mesoapendicular >3 mm, invasión linfovascular o márgenes comprometidos → hemicolectomía derecha.

TUMOR DE 2 CM O MÁS
- Hemicolectomía derecha por mayor riesgo metastásico.

PRONÓSTICO
- Excelente en tumores <2 cm: supervivencia a 5 años >95%.
- Riesgo de metástasis linfonodal: <1 cm <5%; 1–2 cm 5–20%; ≥2 cm 30–40%.
- Síndrome carcinoide y metástasis hepáticas: raros, pero de peor pronóstico.

SEGUIMIENTO
- 1–2 cm con factores de riesgo o ≥2 cm: colonoscopía inicial, TAC/RM cada 6–12 meses y marcadores neuroendocrinos en casos avanzados.
- <1 cm completamente resecados: sin seguimiento adicional.

TENDENCIA ACTUAL
- Tratamiento conservador en lesiones pequeñas; hemicolectomía reservada a casos seleccionados.

